

1. Introducción y relevancia clínica

La **dacriocistitis neonatal** es una **infección del saco lagrimal** secundaria a la **obstrucción congénita del conducto nasolagrimal**, una condición común del lactante que impide el drenaje normal de lágrimas hacia la cavidad nasal.

Como resultado, se acumula material mucoso o purulento en el saco lagrimal, que puede infectarse por bacterias de la flora nasofaríngea o cutánea.

Importancia clínica:

- Es la **causa más frecuente de epífora (lagrimeo persistente) en el recién nacido y lactante menor**.
- Generalmente **benigna y autolimitada**, pero puede complicarse con **celulitis preseptal o abscesos**, y en casos graves, con **sepsis neonatal**.
- Su manejo adecuado en atención primaria previene complicaciones y evita cirugías innecesarias.
- En **EUNACOM**, suele presentarse como un **lactante con secreción ocular crónica** o una **tumefacción dolorosa bajo el canto interno del ojo**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional del sistema lagrimal

El aparato lagrimal se compone de:

- **Glándula lagrimal**: produce las lágrimas.
- **Puntos lagrimales superior e inferior**: recogen la lágrima en el canto interno.
- **Canalículos lagrimales → saco lagrimal → conducto nasolagrimal**: drenan la lágrima hacia el meato inferior de la nariz.

2.2 Mecanismo de la obstrucción

En el **recién nacido**, la causa habitual es la **persistencia de una membrana mucosa en la válvula de Hasner**, ubicada en el extremo distal del conducto nasolagrimal (en el meato inferior nasal).

Esto genera:

1. Estasis lagrimal.
 2. Colonización bacteriana.
 3. Inflamación e infección del saco lagrimal.
-

2.3 Epidemiología

- Incidencia: 5–10% de los recién nacidos.
 - Bilateral en 10–20% de los casos.
 - La mayoría se resuelve **espontáneamente en los primeros 6–12 meses**.
 - El 2–4% puede complicarse con dacriocistitis infecciosa.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- **Epífora persistente:** lagrimeo constante desde los primeros días de vida.
 - **Secreción mucosa o purulenta:** más intensa al presionar el saco lagrimal.
 - **Tumefacción blanda o fluctuante** bajo el canto interno.
 - **Eritema y calor local** en casos infecciosos.
 - En casos graves: **fiebre, irritabilidad o compromiso del estado general**.
-

3.2 Fases clínicas

Fase	Características
Obstrucción simple (no infecciosa)	Lagrimeo sin hiperemia ni secreción purulenta.
Dacriocistitis aguda	Inflamación, dolor, secreción purulenta, eritema local.
Absceso del saco lagrimal / celulitis preseptal	Tumefacción fluctuante, fiebre, riesgo de diseminación.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clínicas
Conjuntivitis neonatal	Secreción difusa sin masa en canto interno, hiperemia conjuntival intensa.
Celulitis preseptal	Inflamación difusa de párpado superior e inferior, fiebre alta, sin lagrimeo constante previo.
Quiste dermoide	Masa firme, no dolorosa, sin secreción ni epífora.
Fístula congénita del saco lagrimal	Orificio con salida de lágrimas espontánea, sin signos inflamatorios.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

En la mayoría de los casos, el diagnóstico es **clínico** y **no requiere exámenes complementarios**.

Criterios clínicos:

1. Lagrimeo constante desde las primeras semanas de vida.
2. Secreción mucosa o purulenta al presionar el saco lagrimal.
3. Masa blanda o fluctuante bajo el canto interno.
4. Conjuntiva generalmente sin hiperemia difusa (diferencia con conjuntivitis).

4.2 Exámenes adicionales (solo en casos atípicos o refractarios)

Examen	Indicación	Utilidad
Cultivo de secreción ocular	Dacriocistitis recurrente o con fiebre.	Identificar bacterias (Staph. aureus, H. influenzae).
Sondaje diagnóstico / irrigación	Casos persistentes >12 meses o sospecha de atresia ósea.	Valora permeabilidad del conducto.
Ecografía orbitaria o TAC	Sospecha de absceso profundo o celulitis orbitaria.	Evalúa extensión.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Objetivos terapéuticos

1. Favorecer el drenaje lagrimal.
 2. Controlar la infección si existe.
 3. Evitar complicaciones locales o sistémicas.
 4. Resolver espontáneamente en la mayoría de los casos sin cirugía precoz.
-

5.2 Tratamiento según fase

A. Obstrucción simple (sin signos de infección)

1. **Masaje del saco lagrimal (maniobra de Crigler):**
 - Técnica: con dedo limpio, presionar suavemente el saco lagrimal (debajo del canto interno) y deslizar hacia abajo 5–10 veces/día.
 - Objetivo: aumentar presión hidrostática para romper la membrana de Hasner.
 - Éxito: 80–90% antes del año de edad.
2. **Limpieza con suero fisiológico** estéril varias veces al día.
3. **Evitar antibióticos tópicos profilácticos** salvo secreción abundante.

B. Dacriocistitis aguda (infecciosa)

1. **Medidas generales:**
 - No realizar masaje durante la fase aguda (riesgo de diseminar la infección).
 - Compresas tibias locales.
2. **Antibióticos tópicos (colirios):**
 - **Cloranfenicol 0,5% o gentamicina 0,3%, 4 veces/día.**
3. **Antibióticos sistémicos:**
 - **Amoxicilina/ácido clavulánico 40–50 mg/kg/día VO cada 8 h.**
 - En casos graves o con fiebre: ceftriaxona EV 50 mg/kg/día.
4. **Derivar a urgencia oftalmológica si:**
 - Compromiso del estado general.
 - Tumefacción fluctuante (absceso).
 - Signos de celulitis orbitaria o preseptal.

C. Casos persistentes (>12 meses o refractarios al masaje)

- **Sondaje del conducto nasolagrimal** bajo anestesia local o general.
 - Éxito 90–95% si se realiza antes de los 2 años.
 - Si fracasa: **intubación con sonda de silicona o dacriocistorrinostomía (DCR).**
-

5.3 Indicaciones de derivación oftalmológica inmediata

- Fiebre o signos sistémicos.
 - Celulitis preseptal u orbitaria.
 - Absceso del saco lagrimal.
 - Fracaso del tratamiento conservador.
 - Persistencia de síntomas >12 meses.
 - Sospecha de atresia completa o masa tumoral.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Conducta
Absceso del saco lagrimal	Colección purulenta con fluctuación.	Drenaje + antibióticos EV.
Celulitis preseptal/orbitaria	Diseminación infecciosa al párpado o órbita.	Hospitalización, ceftriaxona EV.
Fístula lagrimal crónica	Ruptura del saco hacia piel.	Cirugía reconstructiva.
Sepsis neonatal	Diseminación hematógena.	Urgencia vital, antibióticos EV.

Pronóstico:

- **Excelente** en obstrucciones simples (resolución espontánea en 90%).
 - **Muy bueno** con masaje correcto y tratamiento precoz.
 - **Reservado** si complicaciones o retraso en el manejo.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **dacriocistitis neonatal** se presenta desde el nacimiento, mientras que la **conjuntivitis infecciosa** aparece después del 5° día de vida.
 2. **Masaje de Crigler** es el tratamiento de elección inicial y puede evitar sondaje.
 3. **No realizar masaje durante la fase aguda infecciosa.**
 4. La **válvula de Hasner persistente** es la causa más común.
 5. La mayoría de los casos **resuelven espontáneamente antes del año.**
 6. Si hay **fiebre, absceso o celulitis**, el manejo es hospitalario con antibióticos EV.
 7. La **derivación oportuna a oftalmología** evita complicaciones y cirugía tardía.
-

Errores comunes

- Diagnosticar conjuntivitis y tratar solo con antibióticos tópicos.
- No enseñar correctamente la **maniobra de Crigler** a los padres.
- Usar colirios antibióticos prolongadamente sin infección.
- Realizar masaje en fase purulenta aguda.
- Retrasar derivación >12 meses sin resolución.
- No sospechar **celulitis preseptal** ante fiebre y edema severo.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dacriocistitis neonatal** es causada por **obstrucción congénita del conducto nasolagrimal**, generalmente por persistencia de la **válvula de Hasner**.
2. Se manifiesta con **lagrimeo persistente y secreción purulenta** desde los primeros días de vida.
3. El **tratamiento inicial** es **masaje del saco lagrimal (Crigler)**, higiene local y antibióticos tópicos si secreción.
4. En **casos agudos**, agregar **antibióticos sistémicos** y suspender masaje.
5. La **mayoría resuelve espontáneamente antes del año**; casos persistentes requieren **sondaje lagrimal**.
6. Derivar **inmediatamente** ante fiebre, absceso o celulitis.
7. La **educación de los padres** y el **seguimiento regular** son fundamentales para evitar complicaciones y cirugía.